

R_x Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

3B-MEDI

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

Mỗi viên nang mềm chứa:

Thành phần hoạt chất:

- Vitamin B1 (Thiamin mononitrat).....125 mg
- Vitamin B6 (Pyridoxin HCl).....125 mg
- Vitamin B12 (Cyanocobalamin).....250 mcg

Thành phần tá dược: Dầu đậu nành, dầu cọ, lecithin, sáp ong, sorbitan oleat, gelatin, sorbitol liquid, glycerin, methyl paraben, propyl paraben, vanillin, titan dioxyd, idacol green, allura red, nước tinh khiết.

DẠNG BẢO CHẾ

Viên nang mềm.

Mô tả: Viên nang mềm hình oblong, màu hồng đỏ, bên trong chứa hỗn dịch thuốc.

CHỈ ĐỊNH:

- Rối loạn thần kinh ngoại vi: viêm ~~đa dây thần kinh~~, đau dây thần kinh, đau thần kinh tọa, hội chứng vai-cánh tay, đau lưng-thắt lưng, đau thần kinh liên sườn, đau dây thần kinh sinh ba, tê các đầu chi, giảm đau trong đau dây thần kinh, bệnh thần kinh trong đái tháo đường, do thuốc, do nghiện rượu, điều trị hỗ trợ trong đau khớp.
- Các rối loạn do thiếu hụt vitamin B1, B6, B12 (như bệnh beri-beri, viêm dây thần kinh ngoại vi, thiếu máu nguyên bào sắt, chứng co giật ở trẻ em do thiếu pyridoxin).

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG

- Người lớn: 1 viên/lần, 2 – 3 lần/ngày.
- Trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/lần, 1 lần/ngày.
- Dùng điều trị đau dây thần kinh, các rối loạn về thần kinh do nghiện rượu lâu năm: 2 viên/lần x 2 lần mỗi ngày.
- Không dùng thuốc liên tục trên 2 tháng.
- Hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn với một trong các thành phần nào của thuốc.
- U ác tính.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

- Nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu dùng cho trẻ em < 12 tuổi.
- Thuốc này có chứa dầu đậu nành. Nếu bệnh nhân dị ứng với lạc hoặc đậu nành thì không dùng thuốc này.
- Thuốc có chứa 10 mg sorbitol cho mỗi viên nang mềm. Sorbitol là nguồn dinh dưỡng giàu fructose. Nếu bệnh nhân được chẩn đoán có rối loạn dung nạp với một số loại đường nhất định, hoặc nếu bệnh nhân bị rối loạn không dung nạp fructose do di truyền, một số rối loạn di truyền hiếm gặp, mà bệnh không thể tiêu hóa fructose, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này.
- Thuốc chứa glycerin có thể gây đau đầu, rối loạn tiêu hóa nhẹ và tiêu chảy.
- Thuốc chứa methyl paraben có thể gây ra các phản ứng dị ứng (có thể xảy ra chậm).
- Không dùng quá liều chỉ định.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Sử dụng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người đang lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỲ CỦA THUỐC

Tương tác của thuốc

- Isoniazid làm tăng tác dụng đối kháng với vitamin B6 bằng cách ức chế sự tạo thành dạng coenzym của nó.
- Cycloserin và hydralazin cũng là những chất đối kháng với vitamin B6. Việc dùng vitamin B6 làm giảm những ảnh hưởng lên thần kinh của các thuốc này.
- Vitamin B6 làm tăng tác dụng khử cacbon ngoại biên của levodopa và do đó làm giảm hiệu quả của thuốc

trong điều trị bệnh Parkinson.

Tương kỵ của thuốc

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

- Dùng vitamin B6 liều 200mg/ngày và dài ngày (trên 2 tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoại vi nặng, tiến triển từ đáng đi không vững và tê cứng bàn chân đến tê cứng và vụng về bàn tay. Tình trạng này có thể hồi phục sau khi ngưng thuốc, mặc dù vẫn còn để lại ít nhiều di chứng.

- Hiếm gặp.

- Toàn thân: Phản vệ, sốt, ra nhiều mồ hôi, buồn nôn và nôn.

- Ngoài da: Phản ứng dạng trứng cá, mày đay, ngứa, đỏ da.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Quá liều

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Cách xử trí

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Mã ATC: A11DB

Nhóm dược lý: Vitamin B1 đơn thuần và dạng kết hợp của vitamin B6, B12.

- Vitamin B1: Dạng hoạt tính của vitamin B1 là thiaminpyrophosphat có vai trò một coenzym của decarboxylase, transketolase giúp cho quá trình chuyển hóa pyruvat, α -ketoglutarat thành các aldehyd và acid carboxylic và chuyển hóa pentose trong chu trình hexosemonophosphat. Khi thiếu thiamin nồng độ pyruvat trong máu tăng cao và transketolase trong hồng cầu giảm rõ rệt. Tham gia tổng hợp acetylcholin và khử carboxyl của valin, leucin và isoleucin.

- Vitamin B6: Trong cơ thể vitamin B6 bị chuyển hoá thành pyridoxal- 5'-phosphat, một dạng có hoạt tính sinh học của vitamin B6, chất này đóng vai trò như 1 coenzym hoạt tính trong rất nhiều quá trình chuyển hóa, như chuyển hóa các amino acid, nucleic acid, acid béo chưa no, các carbohydrate, dị hóa glycogen và tổng hợp porphyrin.

- Vitamin B12: Có tác dụng tạo máu. Trong cơ thể người cobalamin tạo thành các coenzym hoạt động là methycobalamin và 5-deoxyadenosylcobalamin rất cần thiết cho tế bào sao chép và tăng trưởng. Methycobalamin rất cần để tạo methionin và dẫn chất là adenosylmethionin từ homocystein, khi nồng độ vitamin B12 không đủ sẽ gây ra suy giảm chức năng của một số dạng acid folic cần thiết trong tế bào. Vitamin B12 rất cần thiết cho tất cả các mô có tốc độ sinh trưởng tế bào mạnh như các mô tạo máu, ruột non, tử cung. Thiếu vitamin B12 cũng gây hủy myelin sợi thần kinh.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

- Vitamin B1: Hấp thu ở ruột nhờ quá trình vận chuyển tích cực, liều cao có thể khuếch tán thụ động qua niêm mạc ruột. Bảo hòa ngưỡng hấp thu với liều 8 - 15 mg nhưng chia nhỏ liều và uống rải rác cùng với thức ăn sẽ tăng sự hấp thu.

Thiamin được tập trung cao nhất ở gan, não, thận, tim. Khi các mô quá nhu cầu thiamin sẽ bị thải trừ qua nước tiểu dưới dạng chưa chuyển hóa, hoặc dạng pyrimidin.

- Vitamin B6: Hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hoá trừ trường hợp mắc các hội chứng kém hấp thu. Sau khi uống thuốc phần lớn dự trữ ở gan và một phần ở cơ và não. Thải trừ chủ yếu qua thận dưới dạng chuyển hoá. Lượng đưa vào nếu vượt quá nhu cầu hàng ngày, phần lớn đào thải dưới dạng không biến đổi.

- Vitamin B12: Sau khi uống, vitamin B12 được hấp thu qua ruột, chủ yếu ở hồi tràng. Sau khi hấp thu, vitamin B12 liên kết với transcobalamin II và được loại nhanh khỏi huyết tương để phân bố ưu tiên vào nhu mô gan. Khoảng 3 mcg cobalamin thải trừ vào mật mỗi ngày, trong đó 50 - 60% là các dẫn chất của cobalamin không tái hấp thu lại được.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS

MEDISUN

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN

Số 521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương

ĐT: (0274) 3589 036 - Fax: (0274) 3589 297